DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DİYABET EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

DİYABETLİ BİREY EĞİTİM KİTAPÇIĞI



Hazırlayanlar:
Uzm. Hem. Özgül VATANSEVER
Uzm. Hem. Nalan AYDIN
Uzm. Hem. Belgin BEKTAŞ

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER:

- Diyabet Nedir?..... 2
- Diyabet ve Sağlıklı Beslenme..... 9
- Egzersiz..... 16
- Şeker Düşürücü İlaçlar..... 20
- Diyabet ve İnsülin Tedavisi..... 27
- Diyabet ve Kendi Kendine İzlem..... 46
- Diyabet ve Kronik Komplikasyonlar..... 50
- Koruyucu Ayak Bakımı ve Önemi..... 54
- Diyabet ve Cinsel Yaşam..... 62
- Diyabet ve Genel Sağlık Önerileri..... 64

DİYABET NEDİR?

Günlük yaşamda gerekli aktiviteleri sürdürebilmemiz için vücudumuz **"Glukoz"** adı verilen bir tür şekere ihtiyaç duyar. Glukoz vücudumuza karbonhidratlı yiyeceklerle alınır.

⬇

Besinlerle alınan **glukoz** (şeker) sindirim sisteminden emilerek kana karışır.

⬇

Glukoz (şeker) enerji üretiminde kullanılmak üzere hücre içine girer.

⬇

Hücre içine giren **glukoz** (şeker) oksijen yardımıyla yakılarak enerji, su ve karbondioksite dönüşür ve enerji olarak kullanılır.

⬇

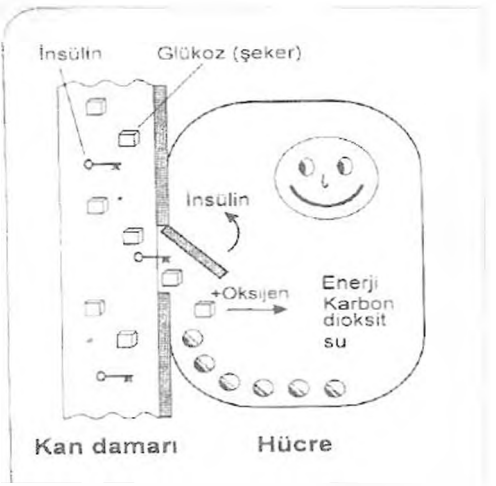
Glukozun(şeker) hücre içine girmesini sağlayan vücudun sol tarafında, karın boşluğunun geri kısmında mideye komşu olarak yerleşmiş yaprak şeklindeki pankreastan salgılanan **insülin hormonudur.**
İnsülin hormonu hücrenin kapısını açmakla görevlidir.

⬇

İnsülin olmadığında <u>glukoz (şeker) hücre içine giremeyecektir</u>.

⬇

Hücreler aç kalacaktır. Glukoz (şeker) kanda birikecek, hücrelerde enerji için kullanılacak bir şey olmayacaktır.



Diyabet;

- Vücudunuzun kandaki Glukoz (Şeker) miktarını kontrol edemediği,
- İnsülin eksikliği sonucu oluşan,
- Kan şekerinin yükselmesi ile karakterize,
- Etkin şekilde kontrol edilmediği zaman çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen ve
- Ömür boyu süren bir hastalıktır.

Eğer insülin hormonu tamamen eksikse bu diyabete **"Tip 1 Diyabet"** denir.

Tip 1 Diyabet, genetik olarak yatkın kişilerde vücudu virüslere ve bakterilere karşı koruyan doğal savunma sisteminin, pankreasta insülin yapan hücreleri tahrip etmeye başlaması ile oluşur. Buna neyin sebep olduğu henüz kesin olarak bilinmemektedir.

İnsülin hormonu var, ama miktarı az ise veya dokularda insüline karşı direnç varsa, bu diyabete de **"Tip 2 Diyabet "** denir.

Tip 1 Diyabetli hastalar yaşam boyu insülin kullanmak zorundadırlar.

Tip 2 Diyabetli hastalar ise diyet, egzersiz ve ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilebilirler. Gerekirse hastalığın ilerleyen dönemlerinde insülin kullanabilirler.

Tip 2 Diyabet, Tip 1 Diyabete göre daha sık görülür.

Tip 2 Diyabetin ortaya çıkışı Tip1 Diyabete göre daha yavaştır, erken belirti görülmeyebilir, yıllarca fark edilmeyebilir.

DİYABET TANISI NASIL KONUR?

Belirti ve Bulgular:



Çok Su İçme



Çok Yemek Yeme



Sık İdrara Çıkma,

Çabuk yorulma, halsizlik, kilo kaybı görülebilir. Bazen de hiçbir belirti hissedilmeyebilir, tesadüfen ortaya çıkabilir.

Diyabet tanısı;

- Günün herhangi bir saatinde ölçülen kan şekerinin: **200 mg/dl ve üzeri,**
- 8 saatlik açlık kan şekerinin: **126 mg/dl ve üzeri,**
- 75 gr toz glukozla yapılan şeker yükleme testinin 2. saatinde ölçülen kan şekerinin:

200 mg/dl ve üzeri olması durumunda konulur.

TİP 2 DİYABET KİMLERDE SIK GÖRÜLÜR?

- Birinci derece yakınlarında diyabet öyküsü olanlarda,
- Kardiyovasküler hastalık öyküsü olanlarda,
- Fazla kilolu kişilerde,
- Tansiyonu 140/90mmHg ve üzerinde olanlarda ve hipertansiyon tedavisi görenlerde,
- İri (4kilo üzeri) doğum yapan, gebelikte gestasyonel diyabet tanısı alan kişilerde,
- Açlık kan şekeri **100–125 mg/dl** arası olan ya da şeker yükleme testinde 2.saat kan şekeri **140 - 199 mg/dl** olanlarda,
- Fiziksel aktivitesi az olan kişilerde,
- Trigiliserid değeri **250mg ve üzerinde** ve/veya HDL kolesterol değeri **35 mg ve altında** olan kişilerde daha sık görülür.

DİYABET TEDAVİSİNİN AMACI NEDİR?

Diyabet tedavisinde amaç kan şekeri yükselme ve düşmelerini önlemek, diyabete bağlı gelişebilecek sorunları engellemek, gelişmiş sorunların seyrini yavaşlatmaktır.

DİYABET TEDAVİSİNİN TEMEL UNSURLARI

Tıbbi Beslenme Tedavisi



İlaç Tedavisi



Egzersiz



Eğitim



Bireysel Kontrol

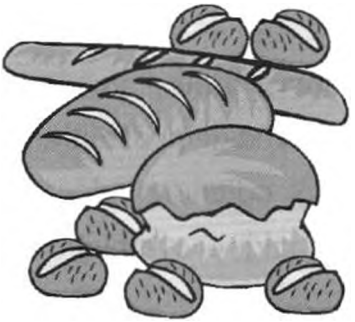


DİYABET VE SAĞLIKLI BESLENME

Beslenme; büyüme, gelişme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besin öğelerinin yeterli ve dengeli olarak alınmasıdır. Beslenmek, hiçbir zaman karın doyurmak anlamına gelmemelidir. Sağlıklı beslenme, besinleri yeterli ve dengeli tüketmek ile mümkündür.

Başlıca besin öğeleri:

> Karbonhidratlar
> Proteinler
> Yağlar
> Vitaminler
> Mineraller
> Su dan oluşur.



Karbonhidratlar;

Karbonhidratlar vücudumuzun başlıca enerji kaynağıdır.

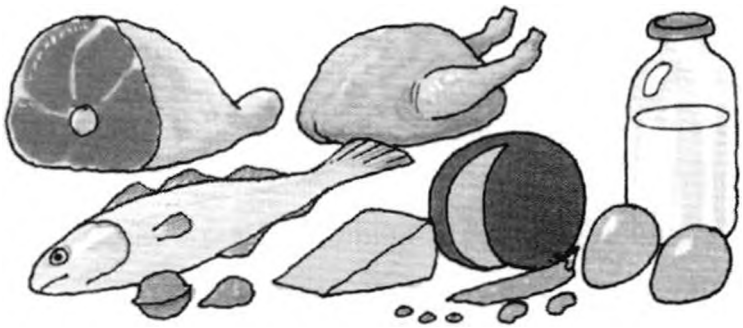
Tüm günlük aktivitelerimizi yapabilmemiz için vücudumuzun enerjiye ihtiyacı vardır.

Ekmek, pirinç, makarna, unlu gıdalar, kurubaklagil gibi gıdalarda karbonhidrat bulunur.

Proteinler;

Besin öğesi olarak proteinlerin birçok görevi vardır. Proteinler vücut hücrelerinin bir kısmını oluşturur. Vücudumuzda deri, kas, kemik ve organlar gibi farklı dokular vardır. Yıpranmış vücut hücrelerimizin onarılması için vücudumuzun devamlı protein alımına ihtiyacı vardır. Yeterli oranda karbonhidrat ve yağ tüketmezseniz proteinler enerjinizi sağlamada katkıda bulunur. İhtiyacınızdan fazla protein alırsanız, proteinler yıkılır ve vücut yağı olarak depolanır.

Et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri hayvansal kaynaklı proteinlerdir. Bu nedenle kaliteli protein olarak adlandırılırlar. **Kurubaklagiller, tahıllar,** bitkisel kaynaklı proteinlerdir.



Yağlar;

Karbonhidratlar ve proteinler gibi yağlar da yaşamımızın sürdürülmesi için gerekli vücut fonksiyonlarını yerine getirebilmemiz ve fiziksel performans için gereken enerjiyi sağlarlar. Yağlar yoğun enerji kaynağıdırlar. Vücudumuz yağları enerji için kullanmakla birlikte, özellikle yağ dokularında ve yağ hücrelerinde depolayabilir. Eğer fazla enerjiye ihtiyaç duyarsak vücudumuz bu yağlardan yararlanır.

Vitamin ve Mineraller;

Karbonhidrat, protein ve yağdan enerji üretimini, vücut proteinlerinin sentezini, yerine getirirler. Bütün taze meyvelerde, sebzelerde, tohumlu besinlerde vitamin ve minareler bulunur.

Posa;

Posa; bitki dokularının sindirim sisteminde parçalanmayan kısımlarıdır. Suda çözünebilen posa ve suda çözünemeyen posa olmak üzere 2 çeşittir.

- **Suda çözünebilen posa; sebze, meyve, yulaf ve kuru baklagillerde** bulunur.
- **Suda çözünemeyen posa; kepek, bulgur ve rafine edilmemiş pirinçte** bulunur.

Posalı gıdalar sindirim kanalında dolgunluk yaratır, barsaklardan emilimi yavaşlatır. Açlık hissinin azalmasına yardımcı olur. Kan glukozunun yavaş yükselmesini sağlar ve böylece dengeli insülin yanıtına yardımcı olur.

Sağlıklı beslenme planınız düzenlenirken yaşınız, cinsyetiniz, vücut ağırlığınız, boyunuz, fiziksel aktiviteniz, sosyoekonomik durumunuz, çalışma koşullarınız, beslenme alışkanlıklarınız göz önünde bulundurulacağından **diyetisyeniniz ve/veya**

doktorunuzun önereceği şekilde beslenmeye dikkat ediniz.

Sağlıklı Beslenme İçin;

- ✓ Öğünlerinizi atlamayınız.
- ✓ 3 ana, 3 ara öğününüzün olmasına dikkat ediniz.
- ✓ Öğünlerde sebze yemeye ve günde 2-3 porsiyon meyve tüketmeye dikkat ediniz.
- ✓ Aşağıdaki besinleri tüketmekten sakınınız.
  - ❖ Şeker, şekerli yiyecekler ve içecekler,
  - ❖ Alkollü içecekler; şarap, rakı, bira, viski, likör vb.
  - ❖ Yağ ve şeker içeriği yüksek olan besinler; pasta, kek, kurabiye, bisküvi, börek, çörek, helva ve diğer şekerli tatlılar, kaymak, krema, ketçap, mayonez, salata sosları, pasta sosları, tahin, tahin helvası
  - ❖ Yağda kızartılmış, kavrulmuş yiyecekler, et, sebze, hamur, patates kızartmaları
  - ❖ Yağlı et ve balıklar, tavuğun derisi, yağlı organ etleri sakatatlar, tam yağlı süt ve süt ürünleri
  - ❖ Şarküteri ürünleri; salam, sucuk, sosis, pastırma, kavurma.

❖Katı yağlar; tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı katılaştırılmış margarinlerden sakınınız.

Tüketeceğiniz Hazır Besinlerin Üzerindeki Besin Etiketini Okuyunuz.

Tatlandırıcı Kullanılabilir Mi?

Yapay tatlandırıcı kullanılmak istenilirse aspartam ve sakarin gibi enerji değeri olmayan tatlandırıcılar kullanılabilir.

Alkol Kullanılabilir Mi?

Diyabetlilerde alkol kullanımı tercih edilmez.

Alkol alımı şeker kontrolü bozuk, şeker düşüklüğü riski yüksek ve kan yağları düzensiz olan bireylerde (ağır hipoglisemi, karaciğer yağlanması, akut kardiovasküler olaylar gibi) sağlık sorunlarına yol açabilir.

Alkol kullanmayı tercih ediyorsanız **erkekler için günlük 2 birim, kadınlar için günde 1 birimdir.**

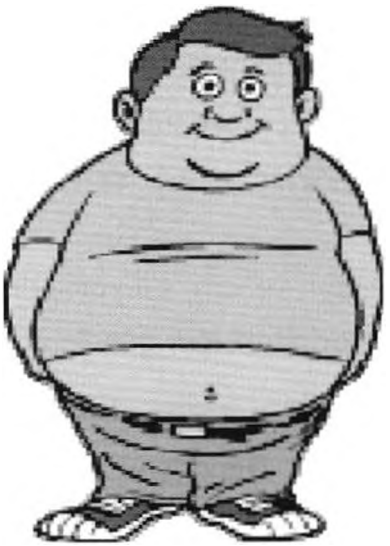
330 ml bira, 1 bardak şarap, 1 duble rakı bir birim alkollü içki olarak tanımlanır. Hipoglisemi riskini azaltmak için alkol besinlerle birlikte alınmalıdır.

Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı;

- ✓ İdeal kiloya ulaşmayı ve /veya korumayı,
- ✓ Kan yağlarını istenilen düzeyde tutmayı,
- ✓ Göz, kalp ve böbrek gibi organlara zarar verecek komplikasyonları önlemeyi veya geciktirmeyi sağlar.

Eğer Kilonuz fazla ise bundan kurtulmanız gerekir;

Fazla kilodan kurtulmak hücrelerin insüline karşı olan direncini azaltır ve kan şekerinizin daha kolay kontrol altına alınmasını sağlar.



EGZERSİZ



Egzersiz Beslenme ve İlaç Tedavisi Kadar Önemlidir!!!!!

- ✓ Kilo kaybınıza yardımcı olur.
- ✓ İnsülin direncinizi azaltarak insülinin etkinliğini arttırır.
- ✓ Kan şekerinizi düşürerek insülin ihtiyacınızı azaltır.
- ✓ Kaslarınızın ve eklemlerinizin güçlenmesine yardımcı olur.
- ✓ Kan yağlarınızın istenilen düzeyde olmasına yardımcı olur.



Egzersizi yemekten 1-1.5 saat sonra yapınız!!!

Kan şeker düzeyinizi egzersize başlamadan önce ve sonra kontrol ediniz!!!

Egzersiz Yaparken:

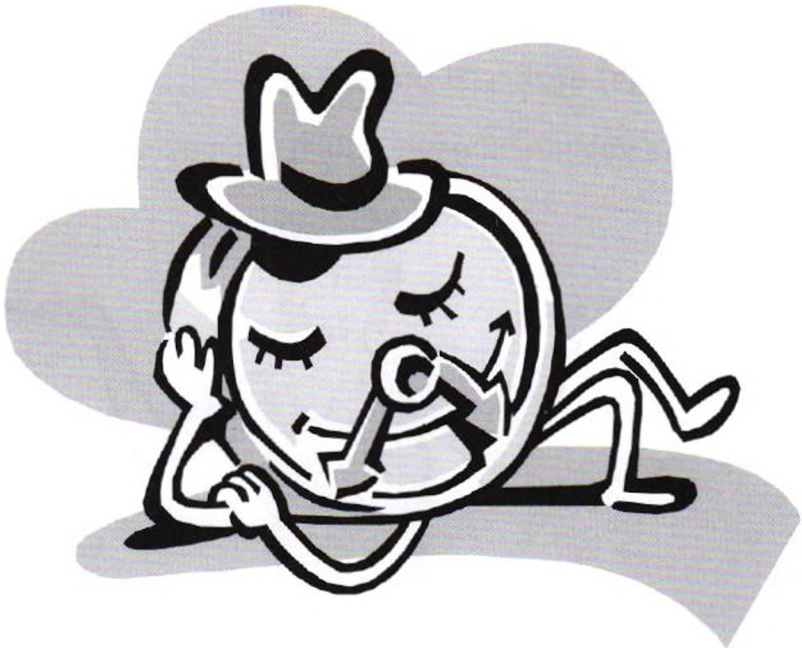
- ✓ Yavaş başlayınız,
- ✓ Egzersiz kan şekerinizi düşürebileceğinden her zaman yanınızda şeker veya meyve suyu bulundurunuz,
- ✓ Egzersiz ayakkabılarınızın rahat olmasına dikkat ediniz,

- ✓ Ağrı hissettiğinizde (göğüs ağrısı, eklem veya bacaklarda) egzersizi bırakınız,
- ✓ Egzersiz yapılan bölgeye insülin yapmayınız.



Eğer;

- ✓ Kan şekeriniz sürekli yüksek ise,
- ✓ Kan şekeriniz düşük ise,
- ✓ Kendinizi yorgun hissediyorsanız,
- ✓ Nefes darlığınız varsa **egzersiz yapmanız sakıncalı olabilir !!!!**



UNUTMAYIN !

HAREKETSİZ YAŞAM

SAĞLIK SORUNLARINI DA

BERABERİNDE GETİRİR.

ŞEKER DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR

(ORAL ANTİDABETİK İLAÇLAR)



Ağızdan alınan şeker düşürücü haplardır. Ağız yolu ile kullanılan ve kan şekeri seviyesini düşürerek diyabet kontrolünü sağlayan ilaçlar farklı şekillerde etki yapmaktadırlar.

• İNSÜLİN SALGILATICI İLAÇLAR

Bu grup ilaçlar pankreası uyararak şeker düşürücü hormon olan insülinin daha çabuk kana verilmesini sağlar. İnsülin kanımızda fazla miktardaki şekerin hücrelere taşınmasını ve enerji olarak kullanılmasını sağlar.

Amaryl, Diameprid, Glimax, Glirid, Glucotrol XL, Minidiab, Diamicron, Diamicron MR, Betanorm, BetanormMR, Gliben, Micronase,Tolinase, Orinase, Glutril gibi ilaçlardan birini kullanıyorsanız;

YEMEKTEN 30 DK ÖNCE ALMALISINIZ.

Daha kısa süre etkili olan insülin salgılatıcı **Starlix, Novonorm, İncuria** ilaçlarından birini kullanıyorsanız;

YEMEKTEN HEMEN ÖNCE ALMALISINIZ.

YAN ETKİLERİNİN;

- Hipoglisemi,
- Bulantı, kusma, iştahsızlık
- Baş ağrısı, baş dönmesi,
- Deri lezyonları,
- Kilo alma,
- Allerji, **olduğunu bilmelisiniz.**

• İNSÜLİN DUYARLAŞTIRICI İLAÇLAR

Bu grup ilaçlar dokuların insüline karşı daha duyarlı olmalarını sağlar. Karaciğerden daha az şeker üretimi sağlayarak kan şekerinin yükselmesini önleyen ve içeriğinde **metformin** bulunan **Glucophage, Glifor, Glukofen, Gluformin, Diaformin** ilaçlarından birini kullanıyorsanız;

YEMEK ARASI VEYA YEMEK SONRASI TOK ALMALISINIZ.

YAN ETKİLERİNİN;

- Şişkinlik,
- Gaz,
- İshal,
- Ağızda metalik tat, **olduğunu bilmelisiniz.**

Kas ve yağ hücrelerinde şekerin daha kolay hücre içerisine girerek kan şekerinin düşmesine yardımcı olan içeriğinde **glitazon** bulunan **Dropia, Glifix, Piogtan** ilaçlarından birini kullanıyorsanız;

YEMEKTEN BAĞIMSIZ
HERGÜN AYNI SAATTE ALMALISINIZ.

YAN ETKİLERİNİN;

- Ödem
- Kilo alma
- Kan yağlarında yükseklik
- Kansızlık
- Baş ağrısı **olduğunu bilmelisiniz.**

• KARBONHİDRAT EMİLİMİNİ YAVAŞLATAN İLAÇLAR

Bu grup ilaçlar karbonhidratların barsaktan emilimlerini yavaşlatarak şekerin vücutta daha iyi kullanılmasına fırsat yaratırlar.

Tokluk kan şekeri yüksekliğinizi düzenleyen **Glucobay, Glynose** kullanıyorsanız;

YEMEKLERİN İLK LOKMASI İLE ALMALISINIZ.

YAN ETKİLERİNİN;

- Karın ağrısı,
- Karında şişkinlik,
- Gaz sancısı **olduğunu bilmelisiniz.**

• İNKRETİN ARTTIRICI AJANLAR

Sindirim kanalındaki hormonları aktifleyip bunların pankreası uyarması suretiyle insülin salgısını arttıran ilaçlardır.

Januvia kullanıyorsanız kahvaltıda veya kahvaltıdan önce,

Galvus kullanıyorsanız yemekten bağımsız alabilirsiniz.

Şeker düşürücü ilaçları kullanırken;

- Diyabet eğitim hemşirenizin ve/veya hekiminizin önerdiği zamanda almaya,
- Bir kutunun bitiminde ilaç kullanımını kesmemeye,
- Beklenen yan etkiler görüldüğünde hekiminize danışmadan ilacı kesme veya dozu değiştirmemeye,
- Başkalarının tavsiyesiyle kendine reçete edilmeyen ilacı kullanmamaya **dikkat** etmelisiniz.

• İNSÜLİN DIŞI ENJEKTE EDİLEN AJANLAR

Byetta kullanıyorsanız ilacınız insülin değildir. Kan şekeri düzeyiniz yemekten sonra yükseldiğinde ilacınız doğru miktarda insülin üretilmesini sağlayarak şekerin enerji üretimi için hücrelere taşınmasını sağlar. Yalnızca kan şekeriniz yükselmeye başladığında kendi insülin üretiminize yardımcı olur, kan şekeri düzeyiniz normale döndüğünde ilacınız çalışmaya son verir.

İlacınız besinlerin mideyi terk etme hızını yavaşlattığı için kendinizi daha çabuk doymuş hissedebilirsiniz, doyduğunuzu hissettiğinizde yemeğinizi kesiniz.

İlacınızı günde **iki defa sabah ve akşam yemeklerinden önce 60 dakika içindeki herhangi bir zaman dilimi içinde enjekte edebilirsiniz.**

Enjeksiyonlarınızın arasında **en az 6 saat** olmalıdır.

YAN ETKİLERİ;

- İştah azalması,
- Baş dönmesi, baş ağrısı,
- Mide bölgesinde ağrı, şişkinlik, hazımsızlık görülebilir.
- Bulantı en sık tedaviye başlandığı anda görülen, zaman içinde azalan yan etkilerden biridir.

Yan etki yaşıyorsanız ve düzelmiyorsa hekiminizle bağlantı kurunuz.

Enjeksiyon Uygulamasında;
Diyabet Eğitim Hemşirenizin ve /veya Hekiminizin Öğreteceği Tekniği Kullanınız!!!!!

DİYABET VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

Pankreasınızdan yeteri kadar insülin salınımı yoksa ihtiyacınız olan insülini dışarıdan almak durumundasınız.

İnsülin; Yerine Koyma Tedavisidir.

Alışkanlık ya da Bağımlılık Yapmaz!

İnsülin tedavileri kişiye özeldir, doktorunuz size uygun olan insülini verecektir.

Bazı kişiler günde 1 kez, bazıları günde 2 kez bazıları ise günde 4 kez insülin yapar. Bu sizin insülin ihtiyacınızın ne kadar olduğuna bağlı olarak değişir.

İNSÜLİN ÇEŞİTLERİ

LANTUS-LEVEMİR (Uzun Etkili İnsülin)

- ✓ Aç olduğunuz zamanlarda ve gece boyunca kan şekerinizi normal düzeyde tutmaya yarar.
- ✓ Genelde günde **1 kez** yapılır. Bazı durumlarda **2 kez de** yapılabilir.
- ✓ **Her gün aynı saatte yapılmalıdır!**
- ✓ **Aç ya da tok yapılması fark etmez!**

HUMALOG-NOVORAPİD-APİDRA

(Hızlı Etkili İnsülin)

- ✓ Berrak görünümlüdürler.
- ✓ Yemek yedikten sonra yükselen kan şekerinizin düzenlenmesi amacıyla kullanılır.
- ✓ Tokluk kan şekeri düzeyiniz üzerine etkilidir.
- ✓ Yemeklerden hemen önce **(5-10dk)** yapılır.
- ✓ Yaptıktan sonra mutlaka yemeğinizi yemelisiniz, yemek yemeyecekseniz bu insülini yapmayınız.

Yemek Saatlerinizin:

Sabah: 07:00 - 09:00 arası

Öğle: 12:00 - 14:00 arası

Akşam: 18:00 - 20:00 arası olmasına dikkat ediniz.

HUMALOG MİX 25-HUMALOG MİX 50-NOVOMİX 30 (Karışım İnsülinler)

- ✓ Bulanık görünümlüdürler.
- ✓ Açlık ve tokluk kan şekerinizin düzenlenmesi içindir.
- ✓ Günde **2** bazen de **3 kez** yapılabilir.
- ✓ Günde **2 kez** uygulayacaksanız; sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden hemen önce **(5-10 dk)** yapılmalıdır. İki insülini uygulama saati arasında yaklaşık **12 saat** olması gerekir.
- ✓ Günde **3 kere** uygulayacaksanız; sabah, öğle, akşam yemeklerinizden hemen önce **(5-10 dk)** yapılmalıdır.

HUMULİN R -ACTRAPİD HM

(Kısa Etkili İnsülin)

- ✓ Berrak görünümlüdürler.
- ✓ Yemek yedikten sonra yükselen kan şekerinizin düzenlenmesi amacıyla kullanılır. Tokluk kan şekeri düzeyiniz üzerine etkilidir.
- ✓ Yemeklerden **30 dakika** önce yapılır.

✓ Yaptıktan 30 dakika sonra mutlaka yemeğinizi yemelisiniz, bu insülini kullanırken ara öğünlerinizi atlamayınız.

HUMULİN M 70/30 -MİXTARD HM 30

(Kısa Ve Orta Etkili Karışım İnsülin)

✓ Bulanık görünümlüdürler.
✓ Yemeklerden **30 dakika** önce yapılır.

HUMULİN N - İNSULATARD HM

✓Bulanık görünümlüdürler.
✓Genelde gece 23:00 de yapılır.
✓Bazı durumlarda sabah ve /veya sabah akşamda yapılabilir.
✓Gece ara öğününüzü almayı unutmayınız.

*****İnsülin tipine göre insülini uygulama zamanları da değişiklik göstermektedir, bu nedenle insülinlerinizi birbirine karıştırmayınız ve diyabet hemşirenizin ve/veya hekiminizin eğitimini dikkatle uygulayınız !!!!!**

İNSÜLİN UYGULAMASI VE BÖLGELER

İnsülinin kana geçebilmesi için cilt altındaki yağlı tabakaya enjekte edilmesi gerekir.

İNSÜLİN UYGULAMASI

✓ **Uygulamayı insülin kalemi ile yapacaksanız;**

İnsülin kalemini ilk kez kullanıyorsanız/ kartuş yeni değiştirildi ise doz penceresinden **2 ünite** ayarlanır, kalem dik tutulur, insülin damlasının kalem ucundan aktığı görülerek kalem/kartuştaki havayı çıkarınız.

Orta etkili karışım insülin kullanıyorsanız, insülin süt gibi beyaz renk alıncaya kadar en az 10 kez avuç içinde yuvarlayınız.

Önerilen dozu, doz penceresinden çevirerek ayarlayınız.

Bir doz uygulamasında 40 ünite insülinden fazla miktar yapacaksanız, dozu ikiye bölerek uygulayınız.

Üzerindeki doz göstergesi görülecek şekilde kalemi avuç içinde **4 parmak** ile kavrayınız, başparmağınızı doza basabilecek şekilde üstte tutunuz.

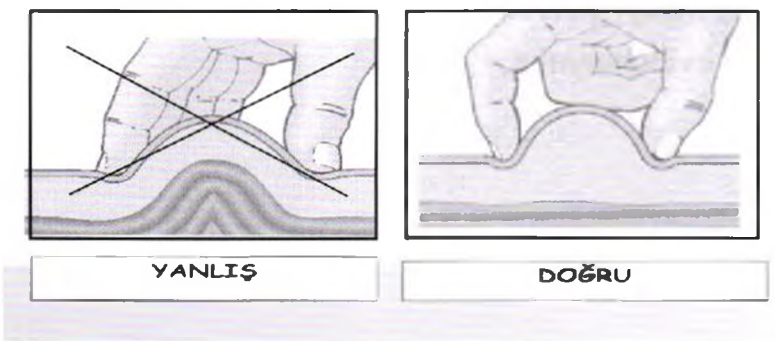
Çimdik tekniği ile bölgeyi kavrayınız.

İğne uzunluğunuz;

4-5 mm ise cildinizi çimdik tekniği ile kavramanıza gerek olmadan 90 derece dik açı ile,

6-8-mm ise cildinizi çimdik tekniği ile kavrayarak 90 derece açı ile uygulamayı unutmayınız.

ÇİMDİK TEKNİĞİ



Gösterge **0**'a döndüğünde **10sn** bekleyiniz/**10**'a kadar sayınız, iğneyi ciltten çıkarınız, sonra çimdiği bırakınız, cildi **ovalamayınız.**

İnsülin enjeksiyonu sonrasında iğneyi kalemden çıkarınız, diğer enjeksiyonda yenisini takınız.

✓ **Uygulamayı enjektörle yapacaksanız;**

İnsülin flakonu/kartuşun tıpasını alkollü pamuk/alkollü mendil ile siliniz, kurumasını bekleyiniz.

Enjektörü dik olarak batırınız, flakonu/kartuşu ters çevirip uygulanacak doz kadar insülini enjektöre çekiniz, hava varsa çıkarınız.

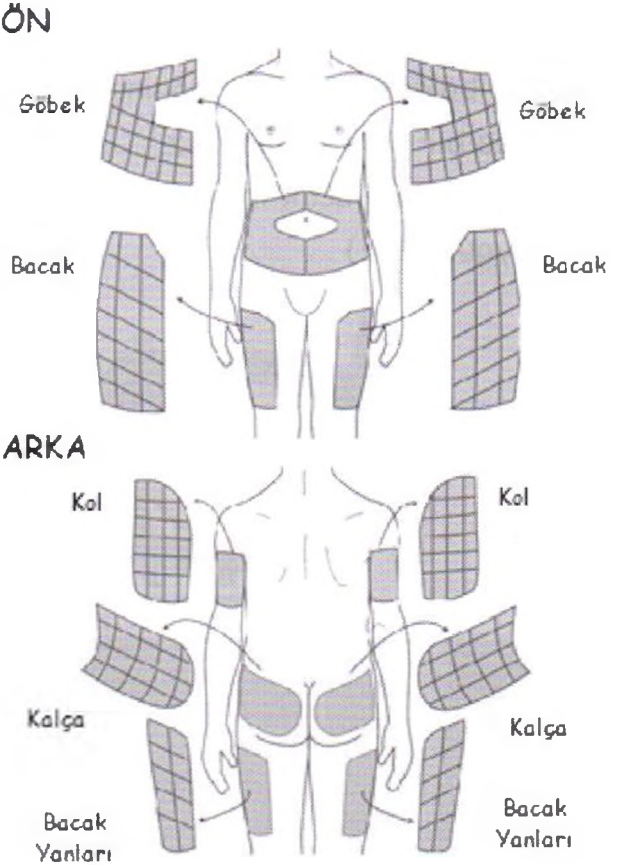
Çimdik tekniği ile insülini, enjektör ucu **13mm** olduğu için **45 derece açı** ile uygulayınız.

İnsülini uyguladıktan sonra iğneyi ciltten hemen çıkarmayınız, **10 saniye** bekleyiniz ya da **10'a** kadar sayınız, iğneyi ciltten çıkarınız, sonra çimdiği bırakınız ve cildi **ovalamayınız.**

Enjeksiyon Bölge Seçimini ve Değişimini Nasıl Yapmalısınız?

✓Haftalık Rotasyon Tekniği:

İnsülini bir hafta aynı bölgeye uygulayınız, saat yönünde haftalık rotasyon



yapınız.

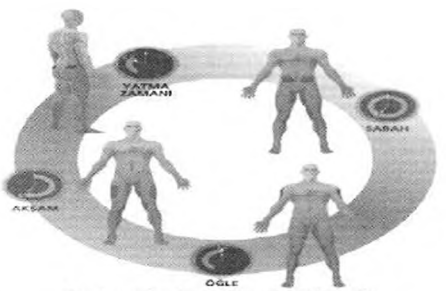
✓Aynı Öğünde Aynı Bölge Tekniği:

Her bir enjeksiyon zamanı için bir bölge belirleyiniz.

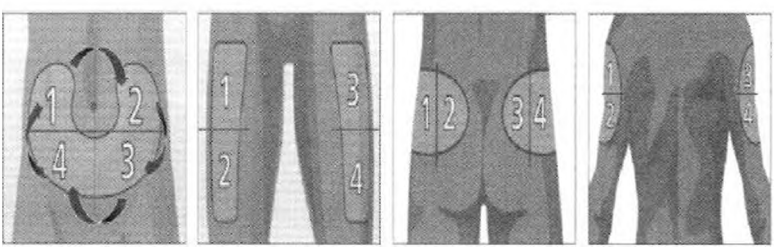
(Örneğin: Sabahları karın, öğlenleri kol, akşamları bacak, yatma zamanında kalça gibi)

Kol, bacak ve kalça sağ, sol olarak kendi içinde ikiye, karın bölgesini dörde bölünüz ve her kadranı saat yönünde bir hafta kullanınız.

(Kalça kullanılmayacak ise yatma zamanı insülini de bacaktan uygulayınız)



Bu durumda, 4 enjeksiyon / günlük rejim



Günde tek doz veya iki doz insülin kullanıyorsanız haftalık bölge rotasyonunu kullanabilirsiniz.

Aynı bölge içindeki insülin uygulamalarınızın arasında **en az bir parmak** mesafe olmasına dikkat ediniz. Enjeksiyonları birbirine çok yakın yaptığınız durumda yağ dokusunda azalma, dolayısıyla insülin emiliminde azalma olacaktır.

İnsülin uyguladığınız bölgede yağ dokusunun kaybına bağlı cilt altında çökme ve ya sert şişlikler oluştuysa enjeksiyonlarınızı bu bölgeden yapmayarak dokunun dinlenmesini ve iyileşmesini sağlayınız.

Giysinizin üzerinden insülin yapmayınız.

İnsülinlerinizi, buzdolabının **dondurucuya yakın olmayan yerinde veya kapak kısmında 2-8°C** arasında saklayınız.

İnsülinlerinizi dondurmamalısınız. Aşırı sıcak veya direkt güneş ışığı altında bırakmamalısınız.

Kullanmakta olduğunuz insülinlerinizi (yedek insülinleriniz hariç) **30°C'nin altında buzdolabına koymadan 28 gün boyunca** kullanabilirsiniz.

HİPOGLİSEMİ
(Düşük Kan Şekeri)

Kan şekeri seviyenizin **70 mg/dl**'nin altına inmesi düşük kan şekeri durumunu oluşturabilir. Ciddi sorunlardan biridir.

NEDENLERİ:

- ✓ Fazla insülin yapılması veya şeker düşürücü ilaçların alınması,
- ✓ İnsülin uygulaması ile yemek zamanı arasından uzun zaman geçmesi,
- ✓ İnsülin uygulaması sonrası çok az yiyecek alınması
- ✓ Gereğinden fazla egzersiz ve /ve ya insülini yaptıktan hemen sonra egzersiz yapılması,
- ✓ Alkol kullanma,
- ✓ Sindirim güçlüğü ve mide boşalmasının gecikmesi.

BELİRTİLERİ:



Açlık Hissi



Terleme ve Halsizlik



Çarpıntı



Baş Ağrısı



Baş Dönmesi



Sinirlilik



El ve Ayakta Titreme

Dilde Ve Dudakta Karıncalanma

Renk Solukluğu

DÜŞÜK KAN ŞEKERİNDE KONTROLÜ ELE ALMAK

✓Diyabetli bir birey olarak yanınızda her zaman en az **10 adet kesme şekeri veya küçük kutu meyve sularından** (vişne suyu posasız olduğundan kan şekerini daha hızlı yükseltir) bulundurmalısınız.

✓İçinde yağ ve protein içeren bisküvi, çikolata gibi gıdalar kan dolaşımına geç katılacağı için tercih etmeyiniz.

✓Düşük kan şekeri belirtileri başladığında **hemen müdahale** etmelisiniz.

✓**4-5 adet kesme şekeri veya bir bardak meyve suyu** (150-200 ml) alınız.

✓**10-15 dakika** bekleyiniz, kan şekerinizi tekrar ölçünüz.

✓Kan şekeri **100 mg/dl üstüne çıkmadıysa** ve belirtileriniz düzelmediyse tekrar **4-5 adet kesme**

şekeri veya bir bardak meyve suyu (150-200 ml) alınız.

✓Kan şekerinizi ölçünüz **100mg/dl üstüne ulaştıysa** ve belirtileriniz geçtiyse kan şekeri düşüklüğünüz düzelmiştir.

✓Bir dilim ekmek ya da 1 bardak süt alınız.

✓**1 saat** sonra tekrar kan şekerine bakınız.

Düşük kan şekeri öğün öncesi olduğunda;

- ✓ **4-5 adet kesme şekeri veya bir bardak meyve suyu** (150-200 ml) alınız **10-15 dk.** bekleyiniz.
- ✓ Belirtiler düzelmiyorsa **yeniden 4-5 adet kesme şekeri ya da 1 bardak meyve suyu** alınız.
- ✓ **10-15 dakika** bekleyiniz, kan şekerinizi tekrar ölçünüz.
- ✓ Belirtiler düzeldikten ve **Kan Şekeri 100 mg/dl üzerine çıktıktan sonra** yemekten önce yaptığınız insülini yemeğinizin sonunda yapınız.
- ✓ 1 saat sonra tekrar kan şekerine bakınız.

EGZERSİZ VE HİPOGLİSEMİ

Egzersiz öncesi kan şekerinizi ölçünüz. **Kan şekeriniz 100mg/dl** altında ise egzersiz programınızı erteleyiniz ya da ek ara öğün alarak egzersiz yapınız.

Egzersiz sırasında hipoglisemi belirtileri hissediliyorsa, egzersize ara verilmeli ve hipoglisemi kontrol altına alınmalıdır.

ALKOL VE HİPOGLİSEMİ

- Alkol miktarı ve aç karnına alkol almak hipoglisemi geçirme olasılığını arttırır.
- Alkol, kan şekeri düzeyi düşmeye başladığında karaciğerden glikoz salınımını azaltır.
- Gece alkol alındıktan sonra birkaç saat içinde bir şey yenmez ise sabahın erken saatlerinde önemli bir hipoglisemi riski olabilir.

Hipoglisemi belirtileri sarhoşluğa benzediği için çevredekiler tarafından hipogliseminin tanınması güçleşebilir, çevredekiler bilgilendirilmelidir.

Bir gece önceden fazla miktarda alkol alındıysa sabah kan şekeri düşük bulunabilir, gerekirse insülin dozu ayarlanmalı ve mutlaka kahvaltı yapılmalıdır.

GLUCAGEN HYPOKİT 1 MG

Hipogliseminizi kontrol altına alamadığınızda bilinç kaybı gelişebilir.

Ağızdan bir şey alamadığınız ve bilinç kaybı geliştiği durumda yakınlarınız size müdahale etmek durumunda kalacaklardır.



Glucagen hypokit 1 mg tek kullanımlık, insulin gibi buzdolabında saklanan ve kullanımı konusunda yakınlarınızın eğitim alması gereken bir ilaçtır.

Glucagen hypokit bir an önce kan şekerini yükseltmek için kullanılır. Etkisini yaklaşık **10-15 dakika** içinde göstererek ciddi hipoglisemi atağını hafifletir.

HİPERGLİSEMİ
(Yüksek Kan Şekeri)

Kan şekerinizin **180mg/dl** üzerinde olmasıdır.

NEDENLERİ:

- ✓ Çok fazla yemek yenilmesi, diyetin bozulması,
- ✓ Kan şekerini düşüren tablet veya insülinin alınmaması yetersiz alınması,
- ✓ Nezle, grip gibi ya da başka bir hastalığın olması,
- ✓ Bozuk ya da tarihi geçmiş insülin kullanılması,
- ✓ Aile içi çatışmalar, okul veya arkadaş problemleri gibi duygusal nedenler,
- ✓ Aktivite azlığıdır.

BELİRTİLERİ:

- ✓ Aşırı susama,
- ✓ Sık idrara çıkma,
- ✓ Bulanık görme,
- ✓ Her zamankinden fazla açlık hissi,
- ✓ Halsizlik, yorgunluk ve uyku hali,
- ✓ Bacaklarda kramp,
- ✓ Ağız kuruluğudur.

***Bu belirtilerin hepsi aynı anda olmayabilir, kan şekeriniz sürekli yüksek ise belirtileri fark edemeyebilirsiniz !!!!!

YÜKSEK KAN ŞEKERİNİ ÖNLEMEK İÇİN

- ✓ Sık kan şekeri ölçümü yapılmalı,
- ✓ Beslenme programına uyulmalı,
- ✓ Bol su tüketilmeli,
- ✓ Düzenli egzersiz yapılmalı,
- ✓ Diyabet tedavisinde kullanılan ilaç ve insülinler düzenli alınmalıdır.

HİPERGLİSEMİ VE EGZERSİZ

Kan şekeriniz 250mg/dl altında ise egzersiz programı yapınız.

Kan şekeriniz 250mg/dl - 300mg/dl arasında ise bacak ve kollarınızda ağrı, kramp yok ise egzersiz yapınız.

Kan şekeriniz 300 mg/dl ve üzerinde ise egzersiz **yapmayınız.**

KETOASİDOZ
(DİYABET KOMASI)

Kandaki şeker, insülin yetersizliği nedeniyle hücre içine giremediği zaman şeker alamayan hücreler enerji elde etmek için yağları yakarlar ve bu durumda **keton** adı verilen atık ürünler oluşur.

Vücut keton cisimlerini idrar ile atmaya çalışır ancak hepsini atamaz ve kanda keton birikmeye başlar ve **ketoasidoz koması** oluşur.

BELİRTİLERİ:

- ✓ Bulantı-kusma
- ✓ Nefes darlığı
- ✓ Ağızda çürük meyve kokusu
- ✓ Şiddetli ağız kuruluğu

Bu belirtiler olduğunda hekiminize haber veriniz veya hastaneye başvurunuz !!!!!

DİYABET VE KENDİ KENDİNE İZLEM



Evde kendi kendine kan şekeri düzeylerinin ölçülmesi **hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) ve hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği)** ataklarının saptanması, gerekli önlemlerin alınması, sorunların erken tanınması veya geciktirilmesi açısından önemlidir.

Evde kendi kendine kan şekeri düzeyleri ölçümü yapıldığında beslenme, egzersiz ve tablet veya insülin tedavisine vücudun verdiği yanıt öğrenilir, daha esnek ve güvenli bir yaşam sürdürülür.

Kan şekeri ölçüm sıklığı kişiden kişiye göre değişir.

DOĞRU KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ YAPMAK İÇİN

- ✓ Kodlama gerektiren cihazlarda ölçüm çubuğu kodu ile kod çipinin aynı olması,
- ✓ Ölçüm çubuklarının nemli ortamda bulundurulmaması,
- ✓ Son kullanma tarihinin geçmiş olmaması,
- ✓ Ölçüm öncesi ellerin temiz olması,
- ✓ Kan akışına yardımcı olmak için parmağın hafifçe sıkılması,
- ✓ Strip için yeterli kanın olması ,
- ✓ Alkol ile temizlenen parmağın kurumadan delinmemesi,
- ✓ İlk damla kanın silinerek ikinci damlanın ölçümde kullanılması **doğru ölçümde önemlidir.**

AÇLIK KAN ŞEKERİ

Şeker düşürücü hapınızı almadan veya insülini yapmadan ve yemeğe başlamadan öğün öncesi ölçülen kan şekeri düzeyidir.

TOKLUK KAN ŞEKERİ

Öğün başladıktan iki saat sonra ölçülen kan şekeri değerini gösterir.

Tokluk kan şekeri ölçüm sonucu açlık kan şekeri ölçümü kadar önemlidir.

Açlık kan şekeri düzeyi normal olduğu halde tokluk kan şekeri düzeyleri yüksek olabilmektedir.

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM SIKLIĞINI NE ZAMAN ARTTIRALIM ???

- ✓ Hipoglisemi ve hiperglisemi yaşıyorsanız,
- ✓ Ağır egzersiz planınız varsa,
- ✓ Alkol alımınız olduğunda gün içindeki ölçüm sıklığını arttırınız.

Kan şekeri ölçüm sıklığını hekiminizin veya diyabet eğitim hemşirenizin önerdiği sıklıkta uygulamaya dikkat ediniz !!!!!

Ölçüm sonuçlarınızı tarih ve öğün zamanına göre belirterek kan şekeri günlüğünüze kaydediniz !!!!!

Kan şekeri günlüğünüzü her kontrolde yanınızda getirip doktorunuza gösteriniz !!!!!

DİYABET
VE
KRONİK KOMPLİKASYONLAR



Diyabet hayat boyunca süren bir durumdur. Kan şekeri kontrolünün sağlanamaması kısa ve uzun dönemde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur.

DİYABETİK RETİNOPATİ

Göz küresinin arka-iç kısmında yer alan retina tabakasındaki damarların hasarıdır.
Hasarın erken evresinde görme etkilenebilir.

Yapılacak olan göz dibi muayenesi ile retinopatinin erken teşhisi önemlidir.

Göz dibi muayenesinde gözbebeklerinin büyümesi için damla damlatılır, gözün arka bölümündeki damarlar ve varsa oluşmuş değişiklikler göz doktoru tarafından saptanır.

Diyabetik retinopati açısından yılda en az bir kez göz dibi muayenesi yaptırınız!!!!!

DİYABETİK NEFROPATİ

Böbreklerdeki kılcal damar bozukluğuna bağlı olarak gelişir.

Diyabetik nefropati görülme oranı, kan şekeri kontrolü sağlanmış kişilerde düşüktür.

Kan şekerini kontrolünün kötü olması yanında yüksek tansiyon (130/80 üstünde), yüksek protein alımı, kan yağları düzeyindeki yükseklikler diyabetik nefropatinin gelişimini etkileyebilir.

İdrarda mikroalbuminüri bakılarak erken dönemde nefropatinin tanısı konulabilmektedir.

Mikroalbuminüri tayini için 24 saatlik idrar tahlili en güvenilir yöntemdir.

Diyabetik nefropati açısından yılda en az bir kez mikroalbuminüri ölçümü yaptırınız!!!!!

DİYABETİK NÖROPATİ

Kan şekeri kontrolünün sağlanamaması sinir hücrelerine zarar verebilir.

Sinir hücrelerinin zarar görmesine **nöropati** adı verilir.

Bazı sinir hücrelerinin hasar görmesi, ayak ve bacakların aşağı kısımlarında ağrı, karıncalanma, uyuşma sızlama, zonklama, yanma gibi şikayetlere yol açar.

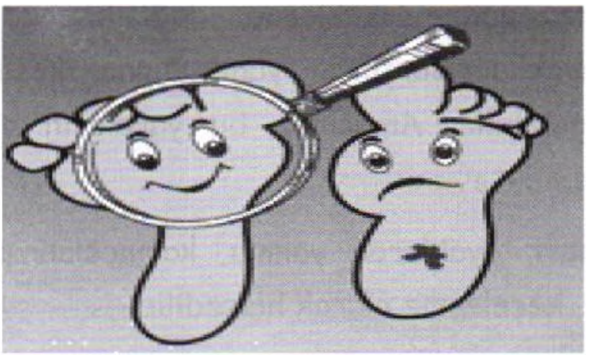
Nöropati ishal, kabızlık, anormal terleme, ayağa kalkarken hissedilen baş dönmesi de yapabilir.

Nöropatinin önlenmesinde kan şekeri kontrolü önemlidir.

Diyabetik ayak oluşumunda nöropati önemlidir, nöropatik ayakta acı hissi azalır, yanma, kesik ve yara oluşumu fark edilmez.

Kan şekeri kontrolsüzlüğü durumunda, kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanmaya bağlı olarak **kalp krizi**, beyin damarlarındaki tıkanmaya bağlı olarak ta **inme** gelişme riski yüksektir.

KORUYUCU AYAK BAKIMI VE ÖNEMİ



Neden şeker hastalarının ayakları risk altındadır?

Yüksek şeker, uzun dönemde sinir hücrelerine zarar verir ve bunun sonucunda;

- ✓ Duyu kaybı,
- ✓ Kas gücü kaybı,
- ✓ Parmaklarda pençeleşme,
- ✓ Şekil bozukluğu,
- ✓ Ciltte kuruluk,
- ✓ Nasır ve
- ✓ Çatlaklar oluşabilir.

Sinir hücrelerinin (nöron) harabiyeti sonucu gelişen bu duruma **Nöropati** denir.

Duyu kaybı; öncelikle ayaklarda çorap, zamanla ellerde eldiven tarzı gelişir. Diyabetik ayak yaraları hissiz hale gelen ayaklarda değişik nedenlerle (çarpma, ayakkabı sürtmesi, yanık, tırnak kesimi vb.) meydana gelebilir. Amacımız bu yaraların olmasını baştan önlemektir.

Nöropati; ayaklarda yanma, karıncalanma, aşırı hassasiyet, keçeleşme olarak hissedilir.

Yüksek şeker yanında kan yağlarınızın yüksek olması ve sigara kullanılmasının etkisiyle damarlarda yetersiz kan akışı olur. Dolaşım yetmezliği problemi olan bu duruma **iskemi** denmektedir.

İskemi nedeniyle ayaklarınızda soğukluk, kızarıklık, parmak uçlarınızda morarmalar ve baldırlarınızda ağrı olabilir.

Nöropati ve iskeminin ayaklarınızda meydana getirdiği rahatsızlıklar kan şekerinizin geçmiş yıllardaki yüksekliğinin sonucudur.

Bu gibi sıkıntılarınız varsa sizi takip eden **doktorunuza** mutlaka söyleyiniz. **Doktorunuz** ayak

muayenenizi yapıp sizi ayak bakımı eğitimine yönlendirecektir.

Şekere bağlı ayak yaraları önlenebilir!

Diyabet eğitim hemşireniz size ayak bakımınızı nasıl yapacağınızı, ayağınızı nasıl koruyacağınızı anlatacaktır.

Koruyucu ayak bakımı ile ayaklarınızda "diyabetik ayak yarası" gelişimini engelleyebilirsiniz.

Diyabetik ayak polikliniğinde ayağınızın risk durumunu ortaya çıkaracak testlerinizi yaptırarak, risk altında iseniz ilgili takip programına hemşireniz sizi dahil edecektir.

Takiplerinizi geciktirmeyiniz.

KORUYUCU AYAK BAKIMI

1- Ayaklarınızı her gün ılık su ile yıkayıp, kurulayınız.

2- Parmak aralarını özellikle kurulayınız, ıslak kaldığında mantar enfeksiyonu oluşur.

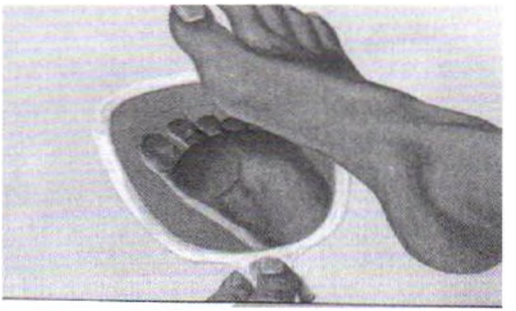


3- Ayaklarınızı yıkayacağınız suyun sıcak olmaması için dirseğinizle suyu kontrol ediniz.

4- Ayaklarınızı nemlendirici bir losyon ile nemlendiriniz, parmak aralarına losyon sürmeyiniz.



5- Ayaklarınızın günlük muayenesini her gün yapınız. Ayak muayenizde ayak sırtını, parmak aralarını ve ayağın tabanını görmelisiniz. Ayak tabanını iyi görebilmek için bir ayna kullanabilirsiniz.



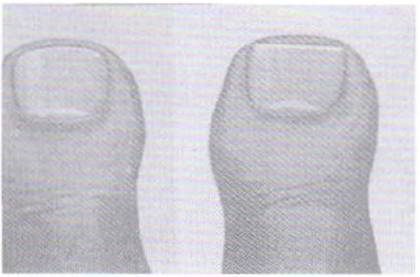
Eğer iyi göremiyorsanız bir başkası günlük ayak kontrolünüzü yapmalıdır.

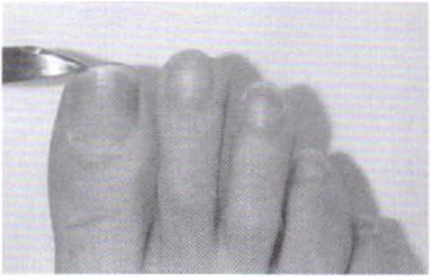
6- Muayene sırasında morluk, siyahlık, kızarıklık, şişlik, kanama, akıntı, kabarcık vb. olağan dışı bir durumla karşılaştığınızda hemen sağlık ekibinize haber veriniz.

7- Nasırlarınız için asitli nasır ilacı, nasır bantları kullanmayınız, nasırlarınızı kesmeyiniz, ayaklarınıza ponza taşı kullanmayınız. Bir uzmandan destek isteyiniz.

8- Tırnaklarınızı banyodan sonra yumuşadığında düz kesiniz, derin kesmeyiniz.

Görme probleminiz var ise tırnaklarınızı bir başkasının kesmesini sağlayınız.

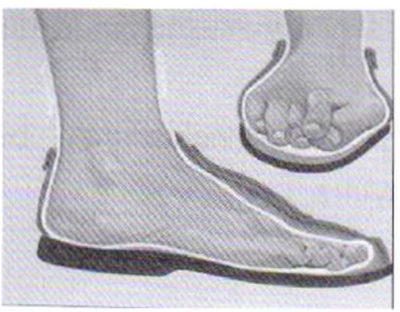




9- Ayaklarınız üşüyor ise sıcağa yaklaştırmayınız, ısıtmak için ısıtıcılar kullanmayınız, kalın çorap, patik vb. kullanabilirsiniz.

10- Ayakkabısız, terliksiz yerlere basmayınız, kumsalda mutlaka terlikle dolaşınız, denize girerken deniz ayakkabısı giyiniz.

11- Ayakkabılarınızın taban genişliği ile ayak tabanınız aynı olmalı, derinliği ekstradan 1 cm fazla ve burnu geniş olmalıdır. Ayakkabı alışverişinizi öğlen saatlerinde yapınız.





12- Ayakkabınızın tabanlığını elinizle kontrol ediniz, kıvrılmış, bozulmuş ise değiştiriniz.

13- Ayakkabılarınızı giymeden silkeleyiniz.

14- Yeni aldığınız ayakkabıyı önce evde aralıklarla deneyiniz, ayaklarınızda şekil bozukluğu varsa ayağınıza uygun özel ayakkabı yaptırınız.

15- Sentetik çoraplar yerine; pamuklu, yünlü, burunları dikişsiz, bilek kısımları sıkı olmayan ve mümkünse açık renk çorapları tercih ediniz.



16- Çorabınız kalın ise ayakkabınızı bağcıklı ve geniş tercih ediniz gerektiğinde bağcıklarını gevşetebilmelisiniz.

17- Ayakkabılarınızın altı dışarıdan yabancı madde batmalarını engelleyebilecek malzemeden olmalıdır.

18- Sigara içiyor iseniz bırakmanızı öneriyoruz !!!!

Ayaklarınızda Aşağıda Belirtilen Durumlar Varsa Hiç Zaman Kaybetmeden Doktorunuza ve Diyabet Hemşirenize Mutlaka Ulaşınız!!!!

1- Ayakkabı sürtmesi veya darlığı nedeniyle ciltte kızarıklık, su toplaması,
2- Ayaklarınızın sıcağa temas etmesi sonucunda yanması,
3- Tırnağınızın kesilmesi esnasında kanama,
4- Nasırlarınızın üstüne dokununca hassasiyet ve ağrı olması, renginin koyulaşması (koyu renk kanamanın işaretidir),
5- Ayakta taban çökmesi, şişlik, şekil bozukluğu,
6- Renk değişikliği morarma, kızarıklık,
7- Ayakkabının altından yabancı cisim batması,
8- Parmak aralarında pişik, kaşıntı, akıntı,
9- Ayağınızın herhangi bir yerinde (tırnak dibi, topuk, ayak tabanı) akıntılı ya da akıntısız yara
10- Ayaklarınızda sıcaklık artışı ve kızarıklık

DİYABET ve CİNSEL YAŞAM



Diyabetli bireylerde görülen en önemli rahatsızlıklardan biri de cinsel fonksiyon bozukluğudur.

Kan şekeri kontrolü sağlanamayan kadın ve erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları görülebilmektedir.

• **Erkeklerde** en sık rastlanan sorunlar; sertleşme problemi (impotans) ve erken boşalmadır.

• **Kadınlarda** ise; cinsel birleşmeyi engelleyen vajinal kuruluk, vajinal enfeksiyon ve mantar enfeksiyonları görülebilir. Vajinal kuruluğa bağlı olarak ağrılı cinsel ilişki olabilir.

Cinsel Sağlık Sorunları Tedavi Edilebilir Mi?

Erkeklerde görülen impotans (erektil disfonksiyon) sorunu; Cinsel teşebbüs sırasında cinsel birleşme için yeterli sertliğin sağlanamaması ve bunun sürdürülememesidir. İmpotansın nedenleri arasında diğer endokrin bozukluklar, psikojenik sorunlar, çeşitli ilaçlar, alkolizm, primer vasküler ve nörolojik hastalıklar sayılabilir.

Diyabette cinsel fonksiyon bozukluğu sadece erkeklerin değil çiftlerin ortak sorunudur. İmpotansın tedavisinde, iyi bir öykü alınıp, nedenler saptanmalıdır. Biyokimyasal ve hormanal tetkikler yapılıp altta yatan sorunlar araştırılmalıdır. Tedavi görmeye karar veren hastalarda medikal tedavi, penise enjeksiyon tedavisi veya penil protez gibi farklı tedavi yöntemleri denenmektedir.

Kadınlarda görülen vajinal kuruluğa bağlı sorunlarda diyabet ekibinin önerdiği uygun kayganlaştırıcı jeller kullanılmalıdır. Diyabetlilerin cinsel yaşamlarının desteklenmesi ile kaliteli ve doyumlu cinsellik yaşanabilir.

DİYABET
VE
GENEL SAĞLIK ÖNERİLERİ

Günlük yaşamda kişisel bakımı sağlama, sürdürme ve özel durumlarda uygulanması gereken bakım önerileri:

CİLT BAKIMI

- ✓ Banyo sırasında tahriş edici uygulamalardan (kese kullanımı vb.) kaçınınız.
- ✓ Cilt nemli iken nemlendirici losyon sürünüz.
- ✓ Vücuttaki istenmeyen tüylerin temizliğinde yaralanmaya neden olabilecek jilet ve ağda kullanmayınız, tüy dökücü kremleri tercih ediniz.
- ✓ Ciltte kesik- çizik oluşmaması için kesici aletleri kullanırken dikkatli olunuz.
- ✓ Cildinizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız, mutlaka koruma faktörü yüksek güneş kremlerini tercih ediniz.
- ✓ Pamuklu iç çamaşırı kullanınız ve her gün değiştiriniz.

- ✓ Ciltte kesik veya çizik oluşmuşsa ılık sabunlu su ile yıkayınız ve temiz malzeme ile kapatınız.
- ✓ Kızarıklık, şişlik, sıcaklık gibi enfeksiyon belirtileri varsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ KORUNMASI

- ✓Dişlerinizi günde en az 2 kez yumuşak bir diş fırçası ile fırçalayınız.
- ✓ Dişleri fırçalandıktan sonra günde bir kez diş ipi kullanılarak diş aralarını temizleyiniz.
- ✓ Diş fırçanızı **3 ayda** bir yenisi ile değiştiriniz, her **6 ayda** bir diş hekimine gidiniz.



- ✓ Diş hekimine gitmeden önce mutlaka kan şekeri kontrolünüzü yapınız.
- ✓ İnsülin kullanılıyorsanız diş tedavisinden önce dozunda ve zamanında insülininizi yapınız ve doz atlamayınız.

SİGARA KULLANIMI



- ✓ Sigara içen diyabetlilerde kronik komplikasyonlar daha hızlı ilerler.
- ✓ Ağız ve diş sağlığı hastalıkları daha fazla görülür.
- ✓ Sigara kullanan diyabetlilere sigarayı bırakmaları önerilir !!!!!!
- ✓ Sigaraya yeniden başlamamak bırakmak kadar önemlidir.

AŞILAMA

Grip aşısı ve pnömoni aşınıza ek olarak seyahat edilecek ülkenin koşullarına göre gerekli olan aşılarınız için hekiminizle görüşünüz.

SEYAHAT



- ✓ Diyabetle ilgili gerekli önlemleri aldığınız sürece sorunsuz bir şekilde seyahat edebilirsiniz.
- ✓ Yolculuk öncesi mutlaka sağlık kontrolü yaptırınız.
- ✓ Sağlık sigortası var ise ilgili işlemleri tamamlayınız ve gerekli evrakları alınız.
- ✓ Diyabet kimlik kartınızı alınız.
- ✓ Yeterli miktarda insülin veya şeker düşürücü hap, glukagon, kan şekeri ölçüm cihazı ve çubuğu alınız.
- ✓ Uzun yolculuklarda yanınıza uygun ve yeterli yiyecek alınız, en fazla 2 saatte bir mola veriniz yada kalkıp dolaşınız.
- ✓ İnsülin veya şeker düşürücü ilaç, glukagon, kan şekeri ölçüm cihazı ve ölçüm çubuğunun bulunduğu çantanızı **kesinlikle bagaja vermeyiniz** yanınızda taşıyınız.

Sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

DEÜ Hastanesi

Diyabet Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Tel: 412 37 51